

Alergias alimentarias

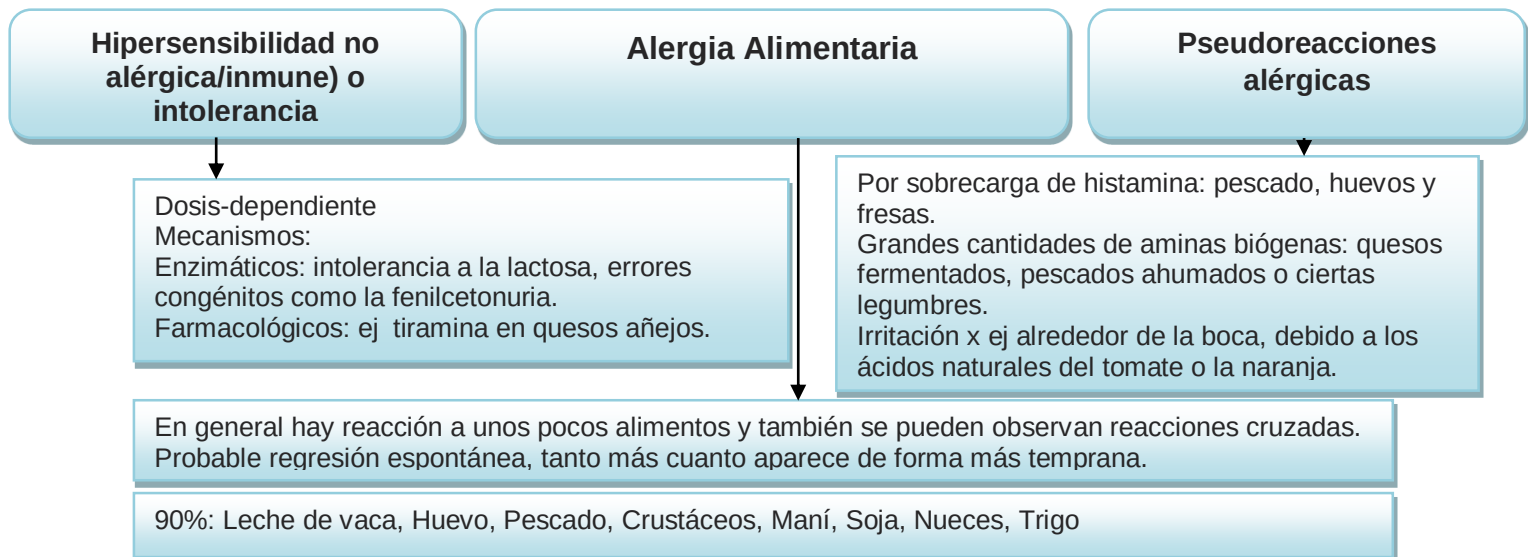
Bibliográfica 2025– Hospital Perrupato – Dr. Navarro David
PRONAP 2024 modulo 3 - Arch Argent Pediatr. 2024;e202410404

Definición: “Reacción adversa de tipo inmunológico debido a la no adquisición o la pérdida de la tolerancia oral y la activación de la respuesta inmune ante una proteína antigénica alimentaria.”

El 90% de los niños afectados por alergias a las proteínas de la leche de vaca, al huevo, al trigo y a la soja alcanzan la tolerancia oral de forma natural con el crecimiento.

En cambio en la alergia alimentaria mediada por IgE, pescados, moluscos, crustáceos, frutos secos y maní, menos del 20% de los casos pediátricos se resuelve y la alergia tiende a persistir durante toda la vida.

Alergia alimentaria más frecuentes según la edad		
Lactantes	Niños	Adolescentes
Leche de vaca Huevo Cereales	Leche de vaca Huevo Maní Almendras Avellanas Soja Trigo Pescado Mariscos	Maní Almendras Avellanas Pescado Mariscos Legumbres Frutas



Factores favorecedores

Frecuencia de su consumo.

Dosis mínimas de antígeno ingeridas en forma aislada o esporádica pueden favorecer la respuesta IgE. Alta capacidad de respuesta Ig E: pacientes “de riesgo atópico”, (antecedentes familiares)

Edad de introducción en la alimentación del niño. El moco de la mucosa intestinal está reducido durante las primeras semanas de vida. Los recién nacidos carecen de Ig A e Ig M en las secreciones exocrinas y la Ig A secretora (s-Ig A) está ausente en el nacimiento y permanece baja durante los primeros meses de vida

El uso de inhibidores de la bomba de protones, más la producción de ácido gástrico relativamente baja durante el primer mes de vida.

La cesárea y la utilización de antibióticos en los primeros meses de vida producen alteración en la formación de una flora intestinal normal.

Mecanismos, manifestaciones y características clínicas de la alergia alimentaria

Reacción precoz o inmediata (Mecanismo IgE-mediado): hipersensibilidad que se caracteriza porque la sintomatología tiene un inicio o aparición brusca (generalmente entre 1 minuto a 2 horas)

Incluye a:

- Alergia oral
- Urticaria
- Angioedema
- Anafilaxia

Reacción tardía o retardada: Mediadas por **LT** (reacción de hipersensibilidad retardada o celulares) y **mixta IgE / LT** (20% de los casos): se caracteriza porque los síntomas se presentan generalmente después de 1 día de la ingesta, por lo que se hace más difícil establecer una relación causa efecto. Los síntomas más frecuentes son los gastrointestinales (diarrea) y los cutáneos (eczema)

Incluye a:

1. Mediada por células T:

- **Gastroenterocolitis:** en > de 6 m alimentados con fórmula. Compromete todo el tracto gastrointestinal. Poco fr. Presentan vómitos, diarrea crónica de tipo malabsortiva, a veces con sangre
- **Enteropatía inducida por proteína alimentaria:** produce diarrea crónica, esteatorrea, distensión abdominal, desnutrición, hipoalbuminemia y anemia
- **Síndrome de enterocolitis inducido por proteína alimentaria:** poco fr. pero habitualmente severo. Ocurre en niños amamantados cuando se introducen fórmulas, presentando vómitos profusos con o sin diarrea, luego de 2 a 4 horas de la ingesta pudiendo causar deshidratación y shock.
- **Proctocolitis:** APLV clásica (las APLV IgE mediadas producen reacciones inmediatas como la anafilaxia).

La anemia es poco frecuente y hay poca repercusión en el estado general y nutricional.

2. Mixtas:

- **Eccema atópico**
- **Esofagitis y gastroenteritis eosinofílica:** más fr en niños > y adultos. Hay inflamación tisular crónica e infiltración por eosinófilos. Requieren endoscopia digestiva y biopsias para su diagnóstico. La LV es el principal alérgeno.

Otras manifestaciones

- Reflujo gastroesofágico, constipación, cólicos e irritabilidad

Exámenes inespecíficos:

Hemáticas por ejemplo, eosinofilia.

En los pacientes que su estado nutricional no es óptimo debe efectuarse hemograma y bioquímica sanguínea nutricional básica:

- Albúmina
- Ferritina
- Calcio
- Fósforo
- Fosfatas alcalinas
- Investigar la materia fecal para determinar sangre oculta (tb. descartar parasitosis intestinal)

Exámenes específicos:

- IgE sérica total

- Pruebas cutáneas de lectura inmediata (PCLI) o Skin-Prick test (miden IgE)

Es el método de elección para demostrar la sensibilización IgE-mediada, debida a su seguridad, fácil realización, resultados inmediatos, bajo costo, reproducibilidad y alto valor predictivo, comparada con la prueba de provocación controlada (PPC).

- Dosaje de IgE específico

- IgE para Betalactoglobulina, caseína, Alfalactoalbúmina y Seroalbúmina (para sospecha APLV IgE mediada)
- RAST: mide IgE presente en el suero del enfermo.
- UNICAP: es más específico

La IgE-específica sérica tiene menor sensibilidad que la PCLI. El resultado debe ser interpretado teniendo en cuenta su correlación clínica.

- **Pruebas de provocación controlada**

Las PPC con alimento son, usualmente, requeridas para confirmar el diagnóstico de AA y adquisición de tolerancia. Otorgan certeza si el alimento sospechoso es causante del síntoma. Al reproducir síntomas y signos de la reacción, deberán realizarla médicos capacitados y en un ambiente controlado. Están contraindicadas en anafilaxia.

Manejo terapéutico

Urticarias

Cuadros agudos: antihistamínicos de primera generación (ejemplo: difenhidramina, hidroxicina): mayor efecto sobre el prurito y efecto sedativo.

Urticarias prolongadas: antihistamínicos de segunda generación (ejemplo: cetericina, loratadina) por su menor efecto sedante.

En ocasiones: 1º generación diurno, 2º generación antes de dormir.

Mala respuesta a antihistamínicos: prednisona 1-2 mg/kg

Dietas de evitación

Serán diseñadas para cada paciente, en general es otorgada por el especialista en alergias pediátricas y nutricionista.

Deben evitarse alimentos con potencial reactividad cruzada: leche (vaca, cabra, oveja), tipos de mariscos, frutos secos (castañas de cajú y pistacho, nuez y pecan), distintas especies de pescados.

Reintroducción del alimento

Será evaluado por el especialista.

Estos niños serán reevaluados cada 1-2 años, de acuerdo con la edad y el alérgeno involucrado.

Se debe monitorear dietas de evitación, lectura de etiquetas, estado nutricional, ingestas accidentales, calidad de vida, situación familiar y comorbilidades.

En la AA IgE-mediada, se realizará la determinación de IgE-específica (sérica y/o PCLI).

En la APLV y la APH, se recomienda testear cada 12-18 meses los primeros 5 años de vida para evidenciar la tolerancia. Si los niveles encontrados son altos, se puede testear cada 2-3 años.

Si el paciente tuvo una reacción alérgica cercana, no deberá testearse inmediatamente.

Cuando la sospecha de tolerancia es alta de acuerdo con la HC e IgE-específica, la confirmación debe realizarse con PPC.

En la AA no IgE-mediada, la PPC se define por HC, endoscopías y biopsias cuando estén indicadas. En proctitis por PLV, la PPC puede realizarse cerca del año (la mayoría adquieren tolerancia a esa edad).

Pronóstico

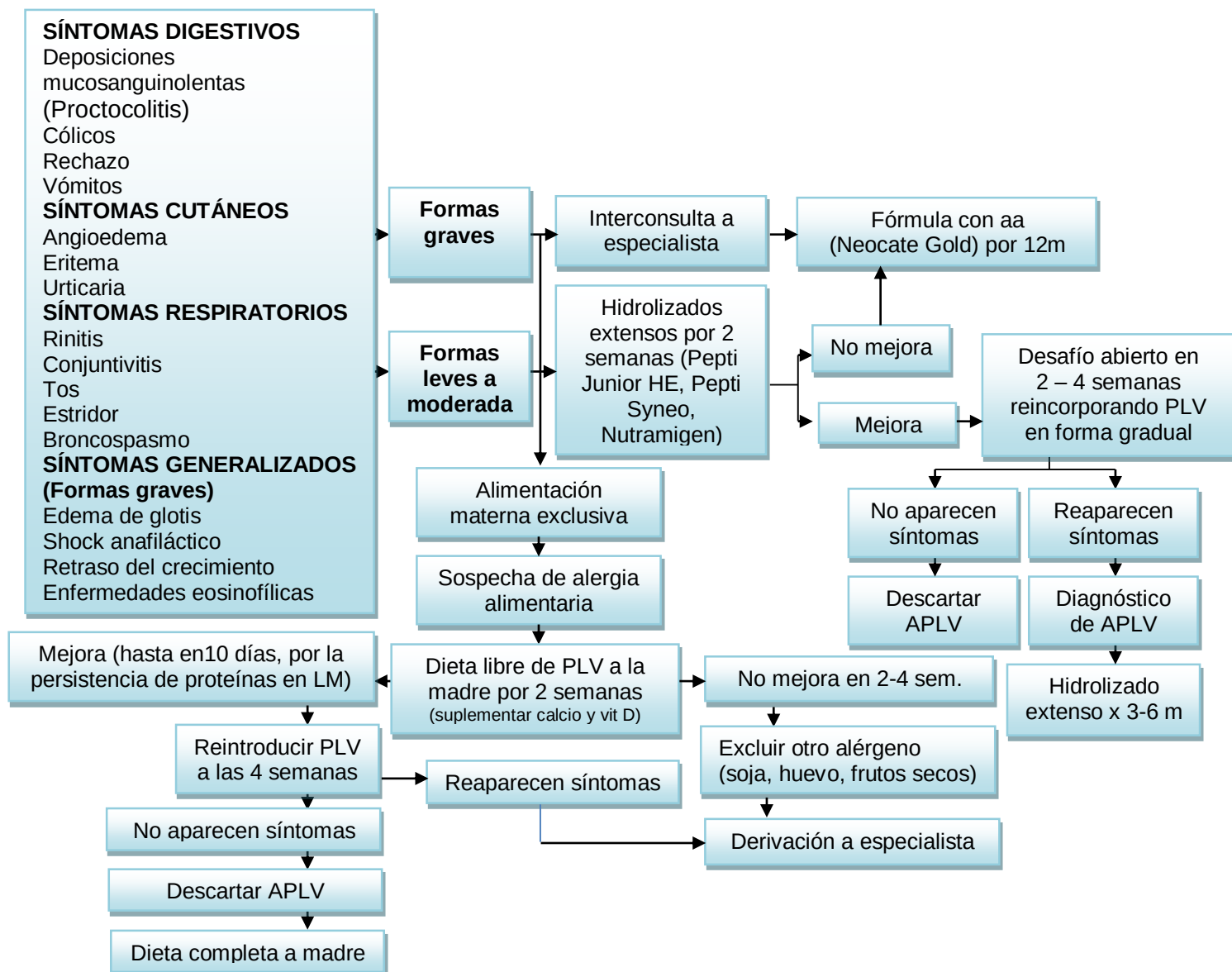
Fenotipo transitorio (logran tolerancia)

- AA de inicio temprano
- No IgE-mediada
- Síntomas predominantemente gastrointestinales
- APLV, huevo, soja, trigo
- Algunas AA IgE-mediadas

Fenotipo persistente (no logran tolerancia)

- IgE-mediadas
- Atopía familiar de predominio materno
- Comorbilidad: asma, rinitis, DA
- Síntomas graves
- Síntomas ante trazas
- PCLI con pápula de tamaño importante y valor elevado de IgE-específica
- AA a maní, frutos secos, pescados, mariscos
- Sensibilización múltiple a alimentos y/o inhalantes
- Persistencia y gravedad determinadas por la proteína responsable (la alergia a caseína persiste más que a seroproteínas).

Algoritmo Alergia a las proteínas de la leche de vaca



En general, los niños con proctocolitis alcanzan la tolerancia alrededor del año.

Utilizar fórmula con hidrolizado extenso de proteínas sin lactosa solamente en aquellos niños con APLV y sospecha de daño intestinal, en forma transitoria hasta la desaparición de los síntomas.

Reintroducción de PLV:

APLV mediada por IgE, SEIPA y enfermedad eosinofílica: primero realizar una IgE específica y/o prueba cutánea para demostrar adquisición de tolerancia (no es rutinaria en las proctocolitis, salvo en dudas con respecto a mecanismos mixtos o necesidad de apoyo diagnóstico). La reintroducción debe hacerse en medio hospitalario. Formas leves y moderadas: ambulatoria.

En caso de reaparecer la sintomatología se deberá suspender la administración de PLV y continuar con el tratamiento de exclusión durante otros 3 a 6 meses.

En niños alimentados con LM: reintroducir leche de vaca y derivados en la dieta materna en forma progresiva, observando aparición de síntomas hasta 4 semanas tras la reintroducción. Luego, continuar con el desafío directamente en el niño.